



AUDIT

“TEST DE IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS POR USO DE ALCOHOL DE LA OMS”

1 ¿QUE ES EL AUDIT?

Es un cuestionario de 10 ítems que mide el consumo problemático de alcohol desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Puede ser autoadministrado o aplicado por un/a profesional de la salud.

Su objetivo no es entregar un diagnóstico clínico, sino detectar el consumo de riesgo en la población y/o en los sujetos antes de que se generen daños mayores.

Posee tres dimensiones: Consumo de riesgo, Síntomas de dependencia y Consumo perjudicial.



ALERTA METODOLÓGICA

2

Los análisis factoriales confirmatorios muestran un problema de dimensionalidad:

Las tres subescalas no se ajustan del todo en la práctica porque el test mezcla conductas, biología y consecuencias del consumo.

Opera bajo un modelo formativo e híbrido, donde conductas externas sumadas construyen el puntaje de riesgo, incluyendo en una misma ecuación las causas (beber) y los efectos (sufrir accidentes).



3 PRESENCIA DE SESGOS

Las propiedades psicométricas no se pueden extrapolar entre culturas.

La equivalencia transcultural se rompe sin la adecuación del “Trago Estándar”. En Europa son 10g de alcohol y en Chile entre 13g y 15g de alcohol (se adaptan las preguntas de frecuencia a nuestra realidad).

Sesgo temporal: en los últimos ítems preguntar si algo ocurrió “alguna vez en la vida” confunde estadísticamente la prevalencia con el riesgo real del presente.

Sesgo de género: aplicar un corte tradicional de 8 puntos, invisibiliza el riesgo en las mujeres, generando falsos negativos debido a su menor tolerancia metabólica al alcohol. La evidencia sugiere bajar el umbral de riesgo en la población femenina a ≥ 5 .



¿CÓMO MEDIMOS EN CHILE?

4

La adaptación chilena validada en Atención Primaria con una buena consistencia interna (Alfa de Cronbach de 0,93), modificó los tramos de la OMS para simplificar la toma de decisiones clínicas:

- Bajo Riesgo: Hombres de 0 a 5 puntos y Mujeres de 0 a 4 puntos, se les entrega psicoeducación.
- Consumo de Riesgo: Hombres de 6 a 8 puntos y Mujeres de 5 a 8 puntos, se realiza intervención breve.
- Perjudicial / Dependencia: Para ambos sexos, un puntaje de 9 o más puntos en Chile enciende alarmas de sospecha. Rompe la tradición internacional de esperar los 16 puntos, la norma chilena unifica el criterio para una derivación a Salud Mental para confirmación diagnóstica.



5

APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA SALUD PÚBLICA

En el programa “Detección, Intervención y Referencia Asistida” (DIR), la aplicación del AUDIT se rige por la edad del consultante.

En la población adulta (≥ 20 años), el AUDIT (o el AUDIT-C) es la herramienta de primera línea en exámenes de medicina preventiva y de controles para sujetos crónicos.

En la población adolescente (10 a 19 años), el AUDIT no es el examen de entrada; por norma, se debe aplicar el CRAFFT, que cuenta con una sensibilidad del 94,2% para captar el problema.

El AUDIT solo se aplica en adolescentes como una herramienta de segunda línea si el CRAFFT da positivo (≥ 2), con el fin de evaluar a fondo la gravedad y los daños orgánicos.

